

종합감사
공개용

부산대학교병원 보험관리팀 감사결과 보고서



2021. 12.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II . 감사대상 현황	6
1. 부서운영 분야	6
2. 주요업무 분야 및 현황	8
III . 감사 결과	13
1. 총평	13
2. 지적사항 총괄	14
IV . 처분요구와 통보사항	15
1. 처분요구사항 일람표	15
2. 처분요구상세	15
가. 임의비급여 처리 방지를 위한 항암제 기준 내 처방 유도	16
나. 진료비 산정특례 적용 착오에 관한 사항	21
다. 전액본인부담(100/100) 적용가능 품목 관리 철저	24
라. 자동차보험 삭감 관련 수가관리 미흡	28
마. 청구 사후관리 및 업무처리 미흡	31
바. 이의신청 부제기 사유 세분화에 따른 삭감관리 철저	34
사. 복무관리[보건휴가(임신검진)] 부적정	36

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 부산대학교병원 보험관리팀(이하 ‘보험관리팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2021년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 보험관리팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 보험관리팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 그리고 보험관리팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원의 규정과 정책 등을 준수하는지의 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사범위는 보험관리팀에서 2018. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 수행한 업무에 한정하여 검토하였다.

1) 보험관리팀-6067(2021. 11. 02.) ‘부산대학교병원 보험관리팀 종합감사 실시통보 및 감사자료 제출’

보험관리팀 종합감사 중점

**1. 보험관리팀 현안 사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 사항
(최우선 중점)**

2. 주요업무에 관한 사항

- 가. 건강보험·의료급여·산재·자보 진료내역 심사에 관한 사항
- 나. 건강보험·의료급여·산재·자보 진료비 청구 후 삭감 및 이의신청 처리에 관한 사항
- 다. 입원 및 외래환자 사후심사에 의한 진료내역 조정에 관한 사항
- 라. 의료수가 책정 및 수가 기준의 관리에 관한 사항
- 마. 건강보험·의료급여·산재·자보 청구 명세서의 보완에 관한 사항
- 바. 건강보험·의료급여·산재·자보 진료비 청구에 관한 사항
- 사. 건강보험·의료급여·산재·자보 진료비 청구 미수액 관리 및 청구통계에 관한 사항
- 아. 건강보험·의료급여·산재·자보 청구 진료비 결손처리에 관한 사항
- 자. 건강보험·의료급여·산재·자보 청구의 행정상 착오에 대한 재청구에 관한 사항
- 차. 기타 소관업무에 관한 사항

3. 부서 운영 등에 관한 사항

- 가. 부서 경비 정산의 적정성에 관한 사항
- 나. 청탁금지법 및 임직원행동강령 준수 여부에 관한 사항
- 다. 일상감사 수감 여부에 관한 사항

4. 복무관리 등에 관한 사항

- 가. 개인 근태관리(휴가 등)의 적정성에 관한 사항
- 나. 관외출장 신청의 적정성 및 출장복명서 제출 등에 관한 사항
- 다. 외부강의 발생 시 신고 현황에 관한 사항

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2021. 11. 01. ~ 11. 05.)를 거쳐 2021. 11. 08.부터 2021. 11. 19.까지 10일간 감사인원 9명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

주요 업무분야의 쟁점을 확인하기 위해 연도별 청구·입금·삭감현황 및 삭감에 대한 이의신청·부제기²⁾ 현황, □□□□□□□□ 불능 건 및 재청구 현황, 외래·입원 산정특례 적용 착오 현황, 퇴원 후 진료비 조정내역, 수가의 신설 및 변경 현황 등의 서류를 제공받아 검토하였으며, 기타 보험관리팀의 일반적인 업무는 전자문서를 열람하여 확인하였다. 또한 부서 운영의 적정성을 검토하기 위해 경비정산내역 및 자산운용현황을 점검하였고, 복무관리 실태를 확인하기 위하여 부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘PHIS’에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선 및 시정이 요구되는 사항, 규정 미준수 및 관리 강화에 관한 사항 등과 관련하여 보험관리팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 보험관리팀장이 참석한 가운데 2021. 11. 18. 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2021. 12. 03. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

2) 청구 후 진료비의 삭감에 대하여 이의신청을 하지 않거나, 하지 못하는 것으로 업무상 편의를 위한 용어.

II 감사대상 현황

1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

보험관리팀은 병원의 진료비 발생과 관련된 수가를 관리하고, 발생한 진료비가 보험기준과 정책에 맞게 발생되었는지를 심사하고 □□□□□□□□□에 진료비를 청구하며 그에 따른 사후관리 업무를 수행하는 부서로서 「부산대학교 병원 직제규정」 제9의2(진료지원부서) 제2항에 따라 진료지원실 밑에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, UM 2명, 팀원 24명 등 총 27명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 보험관리팀 조직도



[표 1] 보험관리팀 인력 현황

※ 기준일: 각 연도별 12. 31.

연도	구분		1급	3급	4급	5급	소계	총계
2018	일반직	간호직	1	11	13	1	26	26
		행정직			2		2	2
		계	1	11	15	1	28	28
2019	일반직	간호직	1	13	11	1	26	26
		행정직			2		2	2
		계	1	13	13	1	28	28
2020	일반직	간호직		14	11		25	25
		행정직			2		2	2
		계	0	14	13	0	27	27

나. 부서예산 현황

최근 3년간 보험관리팀의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 보험관리팀 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
2018	19,400,000	13,647,670	5,752,330	70%	
2019	25,400,000	13,361,790	12,038,220	53%	
2020	27,535,680	16,490,440	11,045,240	60%	

※ 집행률이 70%이하인 사유 : 자보분쟁심의회 분당금(자동차보험진료수가분쟁심의회 수수료)을 매년 책정하고 있고 ◎◎◎◎협회를 통하여 입금요청이 오고 있으나, 전국 국립대학교 병원에서는 이를 납부하지 않는 실정임. 따라서 2019년도부터 우리병원도 수수료는 입금하지 않고 있어 집행률이 70% 이하로 집계됨.

2. 주요업무 분야 및 현황

보험관리팀은 병원을 이용하는 고객들에게 올바른 보험급여의 적용 및 신속·정확한 진료비의 심사를 통해 진료비를 확정하며, 발생한 진료비와 관련된 객관적인 증빙자료를 첨부하여 관련기관에 청구하고, 심사결과를 분석하여 진료과 및 관련 부서와 협의·조정하여 재청구, 이의신청, 심판청구³⁾와 같이 필요한 조치를 취하는 등 적정치료를 위한 진료지원업무를 수행하고 있다. 또한 의료와 관련된 수가(조영제, 치료재료, 행위수가 등)를 관리하고, 관련기관에서 통보하는 각종 지표와 자료를 모니터링하고 분석·적용하는 등 지속적인 진료비의 적정성 향상 활동을 하며, 진료비 관련 통계자료 및 변화하는 의료제도 및 정책에 대하여 병원 직원들에게 교육·홍보·정보제공의 역할을 맡고 있다.

가. 주요업무 내용

보험관리팀 주요업무 내용을 요약하면 [표 3]과 같다.

[표 3] 보험관리팀 주요업무 요약표

주요업무	세부사항
총괄업무	■ 외래 및 입원 삭감(분석 및 방지)관리에 관한 사항 ■ 자료의 분석 및 제출에 관한 사항 ■ 각종 의료보험 및 심사 관련 교육에 관한 사항 ■ 각종 회의 및 위원회에 관한 사항 ■ 대외업무 협의에 관한 사항 ■ 유권해석 및 제도개선에 관한 사항 ■ 의료행위의 표준화 및 세분화에 관한 사항
외래 및 입원업무 (건강보험·의료급여 · 산재·자보)	■ 진료비 심사·청구에 관한 사항 ■ 진료비 삭감에 대한 이의신청 및 심판청구에 관한 사항 ■ 재청구·추가청구·보완청구에 관한 사항 ■ 심사 보완 자료에 관한 사항 ■ 사후심사에 의한 진료내역 조정에 관한 사항 ■ 삭감통보 및 건강보험지침 전달 및 홍보에 관한 사항 ■ 진료비 민원에 관한 사항 ■ 공상환자 진료비 청구 및 관리에 관한 사항

3) 위법 또는 부당한 처분을 받거나 필요한 처분을 받지 못함으로써 권리 또는 이익의 침해를 받은 자가 그 처분의 취소·변경이나 필요한 처분을 청구하는 불복절차로, 이의신청을 거쳐 심판청구를 하거나 직접 심판청구를 할 수 있음.

주요업무	세부사항
	■ 허가초과 항암제 사용에 관한 사항 ■ 허가초과 인정비급여 약제·치료재료대 사용에 관한 사항
청구미수금관리업무	■ 청구 미수금 정산·결산 및 통계보고에 관한 사항 ■ 진료비 결손처리에 관한 사항
수가관리업무	■ 의료수가 책정 및 수가 기준 관리에 관한 사항 ■ 의료수가 조정·적정성 분석 및 개선에 관한 사항 ■ 치료재료 구매내역 신고에 관한 사항 ■ 진료재료대(의약품 포함) 구입·소명자료제출에 관한 사항
기타업무	■ 각종 서무에 관한 사항 ■ 기타 소관업무 및 원장이 필요하다고 인정하는 사항

나. 진료비 청구·삭감·이의신청 현황

보험관리팀은 진료비 심사 및 관리 업무를 통해 청구의 누락·오류를 줄여 업무의 효율을 높이고 다양한 분석을 통해 진료비의 삭감을 방지하고 최소화할 수 있도록 노력하고 있다. 그 결과 [표 4]와 같이 2016년 대비 현재(2021.10.31.)의 삭감율은 2배 이상 감소 추세를 보이고 있으며, 최근 3년간 진료비 청구 및 삭감에 대한 이의신청율은 [표 5]와 같이 증가하여 심사업무의 효율을 극대화 시켰다.

[표 4] 보험관리팀 진료비 삭감 추이

(단위:원,%)

년도	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 현재
삭감액	2,085,539,309	2,238,470,930	2,116,662,546	1,335,534,261	1,262,517,881	913,625,040
삭감율	0.77	0.77	0.60	0.35	0.33	0.3

[표 5] 최근 3년간 진료비 청구·삭감·이의신청 현황

(단위:건,원,%)

구분	청구건수	청구총진료비	원내+원외삭감액	삭감율	이의신청액	이의신청률
2018년	1,054,933	353,838,987,320	2,116,662,546	0.6	1,111,131,197	52.49
2019년	1,087,819	387,022,179,810	1,335,534,261	0.35	921,809,179	69.02
2020년	1,028,003	386,365,886,880	1,262,517,881	0.33	831,504,105	65.86

다. 수가 관리 현황(코로나-19관련 수가 포함)

보험관리팀은 병원의 전반적인 의료수가를 관리하며, 정책과 상황에 맞는 수가를 신설·조정하는 역할을 하고 있다. 예기치 못한 코로나-19 상황에 적합하게 대응하기 위하여 중앙방역대책본부지침 및 코로나바이러스감염증-19 대응지침을 반영한 ○○○○○○ 보험급여과 공문 및 고시에 따라 신속하게 코로나-19 관련 의료수가를 신설·조정하고, 이를 병원에 적용하는 등 체계적인 과정을 통해 환자에게 적정치료를 제공할 수 있었으며, 그 현황은 [표 6]과 같다.

[표 6] 2020년 코로나-19 관련 적용수가 현황

수가명	수가코드	발생건수	발생액	관련근거(고시)
핵산증폭-정성그룹4_코로나바이러스감염증-19[실시간역전사중합효소연쇄반응법]	D658404	5,433	445,902,676	○○○○○○ 고시 제 2020-31호 ('20.2.6.)
안심병원 감염예방관리료_입원	AH320	5,114	106,162,300	○○○○○○ 보험급여과-920호 (2020.2.22.)
안심병원 감염예방관리료_외래	AH310	2,060	42,580,360	○○○○○○ 보험급여과-920호 (2020.2.22.)
코로나19 음압격리실 입원료-1인용	AH101	852	512,306,760	○○○○○○ 보험급여과-1376호 ('20.3.23)
코로나19 음압격리실 입원료-1인용/오전0-6시입원	AH101100	1	299,800	○○○○○○ 보험급여과-1376호 ('20.3.23)
코로나19 음압격리실 입원료-1인용/18-24시퇴원	AH101200	11	3,297,800	○○○○○○ 보험급여과-1376호 ('20.3.23)
코로나19 음압격리실 입원료-다인용	AH102	1497	510,466,040	○○○○○○ 보험급여과-1376호 ('20.3.23)
코로나19 음압격리실 입원료-다인용/오전0-6시입원	AH102100	3	507,960	○○○○○○ 보험급여과-1376호 ('20.3.23)
코로나19 음압격리실 입원료-다인용/18-24시퇴원	AH102200	16	2,742,980	○○○○○○ 보험급여과-1376호 ('20.3.23)
핵산증폭-정성그룹4_코로나바이러스감염증-19[핵산증폭법]응급용선별검사Ⅱ	D658499	64	5,212,472	○○○○○○ 고시 제 2020-151호 ('20.7.16.)
응급의료관리료-선별진료소	AC1011	349	18,934,920	요양기관 정보마당 코로나19 비상상황 대응 간호간병통합서비스 기준 한시적 조치사항 안내 (2020.12.16.)
코로나19 중증환자전담치료병상 중환자실입원료-간호1등급	AH181	53	22,366,530	○○○○○○ 보험급여과-6131호 (2020.12.24.)
코로나19중증환자(전담치료병상)중환자실입원료-간호1등급(18-24시퇴원)	AH181200	1	211,000	○○○○○○ 보험급여과-6131호 (2020.12.24.)
코로나19 중증환자(전담치료병상)중환자실 내 음압격리관리료	AH150	53	34,721,800	○○○○○○ 보험급여과-6131호 (2020.12.24.)

또한 코로나-19와 같은 국가재난상황으로 2020년에는 수가심의 대상 건수가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났으며, 최근 3년간 보험관리팀에서 진행한 수가심의 현황 결과는 [표 7]과 같다.

[표 7] 최근 3년간 수가심의 현황 결과

구분	2018년		2019년		2020년	
	가결	부결	가결	부결	가결	부결
신규	192	73	212	69	201	68
조정	496	0	451	0	800	67
계	688	73	663	69	1001	135

다. 청구 주상병 확인

○○○○○의 「상급종합병원 지정 및 평가 규정·지침」 일부 개정 및 발령(2020.06.30.)에 따라 전문진료질병군에 속하는 입원환자의 비율이 전체 입원환자의 44% 이상인 경우, 단순진료질병군에 속하는 입원환자의 비율이 전체 입원환자의 8.4% 이하인 경우 만점을 받도록 지정기준이 변경되어 상급종합병원 지정에 경증·중증 환자 비율이 큰 영향을 미치게 되었다. 이에 보험관리팀은 상병코드 입력과 관련된 사항을 점검·분석하여 오류를 막고 질환에 맞는 상병코드를 입력하기 위해 보건의료정보팀과 유기적인 협력을 통하여 의사의 상병코드와 청구코드가 일치하고, 환자별 진료질병군에 맞는 상병코드를 입력하도록 철저한 상병코드 관리를 통해 [표 8]과 같은 성과를 이루었다.

[표 8] 상병코드 관리를 통한 진료질병군 주상병 일치 현황 (단위:%)

분기 \ 질병군	전문 [44%▲]	일반	단순 [8.4%▼]	불능
2020년 3분기	45.47	48.19	6.38	0.57
2020년 4분기	45.77	47.23	7.00	0.65
2021년 1분기	47.52	45.95	6.54	0.59
2021년 2분기	48.63	44.8	6.57	0.63
2021년 3분기	47.25	46.27	6.49	0.56

라. 업무개선을 위한 활동

보험관리팀은 의료환경의 변화에 따라 쏟아지는 각종 정책과 세부지침·고시의 내용을 분석하여 업무에 적용하고 진료과 및 관련 부서에는 정보 제공 및 교육을 시행하며, 나아가 정부의 제도 시행에 맞추어 발빠르게 대처하고 있다. 최근 3년간 보험관리팀에서 고시 및 세부지침을 업무에 적용한 현황은 [표 9]와 같고, 고시반영에 필요한 업무개선을 위한 전산개발 현황은 [표 10]과 같다.

[표 9] 고시 및 세부지침 업무적용 현황

년도	2018년	2019년	2020년
건수	171건/총 315건	187건/총 343건	198건/총 343건

[표 10] 업무개선을 위한 전산개발 현황

년도	2018년	2019년	2020년
건수	24건	50건	74건

마. 부서운영경비 사용 현황

최근 3년간 보험관리팀의 부서운영경비 사용 현황은 [표 11]과 같다.

[표 11] 보험관리팀 부서운영경비 사용 현황

(단위: 천원, %)

연도 업무추진비내역	2018			2019			2020		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	4,860	4,860	100	5,400	5,400	100	5,408	5,408	100

III 감사결과

1. 총평

보험관리팀의 주된 업무는 병원에서 실시한 요양급여에 대한 심사 및 청구와 이에 따른 조정이며, 이러한 업무를 통해 진료내역의 적정성을 평가하여 양질의 의료서비스를 제공하고, 삭감을 최소화하여 의료 수익을 개선하는 등 심사업무의 효율을 극대화하여 병원경영에 이바지하고 있다.

이번 종합감사에서는 보험관리팀의 전체적인 업무의 흐름을 파악할 수 있었으며, 입원 월 2회, 외래 월 1회의 주기적인 청구를 시행함으로써 누락 없는 정확한 청구를 가능하게 하였고, 최근 3년 동안의 평균 삭감율은 0.43%로 상급종합병원의 평균 삭감율 0.5%보다 낮았으며, 이의신청율 평균은 62.46%로 기본 50%보다 높은 것으로 나타나 전문성에 기반한 체계적이고 일관성 있는 심사업무 및 관리가 이루어지고 있음을 확인하였다.

이전과 다르게 주목할 점은 2019년 말부터 시작된 범유행전염병인 코로나-19의 장기화로 인해 수가관리 업무의 비중이 눈에 띄게 늘어났으며, 보험관리팀의 신속하고 적극적인 코로나-19 관련 수가의 개선은 감염병 대유행 상황에서 진료의 즉시성을 제공하는데 큰 도움을 주었으며, 나아가 공공의료기관으로서의 책임과 기능을 수행하는데 있어 중요한 역할을 하였다.

또한 원칙적으로 인정되지 않는 임의비급여 처리를 방지하기 위해 보험관리팀에서 기울인 노력은 기준 내 항암제 처방 유도를 성공적으로 이끌어내어 대외적으로는 정부의 의료정책 및 제도에 합리적으로 대처하고, 각종 외부기관의 실사 및 감사에 긍정적인 평가를 기대할 수 있으며, 내부적으로는 허가기준

외 처방을 제한함으로써 민원·소송 등의 문제를 미연에 방지하고, 진료비 삭감 최소화 및 병원수익증대 등의 기대효과를 창출한다는 점에서 모범사례로 추천하였다.

그러나 이번 감사를 통해 보험관리팀 업무시스템의 취약점 및 개선·보완 사항들도 드러나 확인한 결과, 반복적으로 발생하는 진료비 산정특례 적용 착오는 행정력 낭비 및 병원신뢰도 하락을 초래하므로 적용 착오를 최소화할 수 있는 개선 방안을 마련토록 하고, 환자에게 전액본인부담(100/100)이 가능한 품목의 청구 및 삭감을 방지하기 위하여 관리 강화 및 대책을 강구토록 권고하였다. 더불어 자동차보험진료수가 관리가 미흡하여 기준에 맞는 별도의 수가관리가 가능하도록 업무 개선을 요구하였으며, 청구 후 처리되지 않은 반송 건에 대해서는 빠른 시일 내에 재청구 될 수 있도록 시정조치 하였다. 그리고 타부서와 협의를 통한 업무에 대해서는 위임전결규정에 따라 결재권자의 승인을 득하여 문서로 업무를 처리하도록 하고, 단일화 된 이의신청 부제기 사유는 오해를 불러일으킬 소지가 충분하다고 판단되어 구체적인 사유를 명시하여 구분 관리하도록 통보 조치하였다. 끝으로 복무점검 결과 보건휴가(임신검진)를 초과하여 사용한 사실이 확인되어 초과 사용분(80,280원)에 대해 환수하도록 시정요구하였다.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현 지 조 치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
7	80,280원				2 (80,280원)			1	2	2				1		

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	보험관리팀	임의비급여 처리 방지를 위한 항암제 기준 내 처방 유도	통보 (모범사례)	-	-	-	
2	"	진료비 산정특례 적용 착오건에 관한 사항	권고	-	-	처분 후 2개월내	
3	"	전액본인부담(100/100) 적용 가능 품목 관리 철저	권고	-	-	"	
4	"	자동차보험 삭감 관련 수가관리 미흡	개선	-	-	"	
5	"	청구 사후관리 및 업무처리 미흡	시정요구 및 통보	-	-	"	
6	"	이의신청 부제기 사유 세분화에 따른 삭감관리 철저	통보	-	-	"	
7	"	복무관리[보건휴가(임신검진)] 부적정	시정요구	80,280원	-	"	

2. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

통 보(모범사례)

제 목 임의비급여 처리 방지를 위한 항암제 기준 내 처방 유도

소관부서 부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 부산대학교병원 보험관리팀

모범사례 선정사유

■ 수가의 적정 관리

- 적정진료의 유도 및 내부적 인지·교육의 기능
- 양질의 의료서비스 제공을 통한 질 향상
- 삭감 최소화 및 수익증대에 기여

■ 공공의료기관으로서의 역할 충실

- 건강보험제도 적극 수용 및 합리적 대응

- 임의비급여란 보험수가로 정해지지 않은 것에 대하여 병원이 임의로 비급여하여 가격을 산정한 진료항목을 말하며, 법에 규정된 급여 및 비급여 어디에도 해당되지 않아 현행법 상 환자 본인이 전액 부담하는 임의비급여의

적용은 불법적으로 비용을 부담케 한 행위로 간주되어, 병원에서 그 비용을 환급해야 하고, 월 평균 부당금액 0.5% 이상일 경우 업무정지 및 과징금이 부과되는 등의 행정처분을 받게 된다.

- □□□□□□□□에서는 항암화학요법과 관련한 공고내용 전문을 포함하여 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」과 인정되고 있는 허가초과 항암요법, 검토중이거나 급여로 인정되지 아니한 요법 등을 홈페이지에 게시하여 유익한 정보를 제공하고 있으며, 허가된 항암화학요법에 대한 처방 기준을 요약하면 [표 1] 과 같다.

[표 1] □□□□□□□□ 항암화학요법 처방 관련 기준 요약

▶ □□□□□□□□ 허가된 항암화학요법

가. 항암화학요법 등 공고내용에 따라 처방

나. 허가초과 항암요법 신청

요양기관의 항암치료다학제적 위원회 승인 절차 필수

1) 기 인정요법 신청

- 2018.7.1. 이후 다른 요양기관에서 신청하여 기 인정된 요법을 사용하고 자 하는 요양기관은 □□□□□□□□장의 승인절차 없이 다학제적 위원회 협의 후 □□□□□□□□ 신고일(접수일)로부터 사용

2) 신요법 신청

- 공개된 기 인정된 요법과 동일하여야 하며, 용법·용량 등 다르게 사용하고 자 하는 경우 신요법으로 다시 신청·승인 절차 필요

3) 허가초과 항암요법 사용 후 □□□□□□□□에 전년도 사용내역 제출

- 우리병원은 공공의료기관으로 외부기관으로부터 주기적인 실사 및 감사를 받는 실정이므로 이에 대한 대비가 필수적이며, 실손보험의 증가로 보험회사측에서 수진자의 본인부담금(비급여) 과다에 대한 민원을 □□□□□□□□□□으로 제기하는 사례가 급증하여 우리병원에도 실손 보험사의 민원에 대한 전액 환불결정이 통보되었기에 이에 대한 해결방안 마련이 우선적으로 대두되었다.
- 이에 보험관리팀은 퇴원일자 기준 2017.01.01.부터 2020.04.16.까지 진료과별로 항암제 임의처방(100/100) 현황을 [표 2]와 같이 조사하여 현 실태를 파악하고, 이를 근거로 진료처장 및 진료지원실장을 필두로 해당 진료과장들과 회의를 소집하여 허가초과 항암제 처방 건에 대한 대책을 논의하고 해결방안을 모색하도록 업무를 추진하였으며 진행 과정은 [표 3]과 같다.

[표 2] 진료과별 항암제 임의처방(100/100) 현황

(단위:원)

2017년		2018년		2019년		2020년(4.16까지)	
진료과	금액	진료과	금액	진료과	금액	진료과	금액
외과	31,177,621	호흡기 알레르기내과	54,380,315	혈액종양내과	105,172,876	혈액종양내과	17,152,445
혈액종양내과	26,379,652	혈액종양내과	51,757,960	호흡기 알레르기내과	24,723,804	산부인과	14,609,737
비뇨의학과	18,097,282	산부인과	21,685,116	산부인과	17,863,886	외과	1,610,098
호흡기 알레르기내과	9,789,001	비뇨의학과	21,422,246	비뇨의학과	6,949,314	호흡기 알레르기내과	1,505,448
산부인과	3,500,993	소화기내과	1,883,652	외과	3,224,113	내분비대사내과	1,131,070
기타 진료과	1,461,119	외과	1,469,623	소화기내과	1,977,823	임의100/100 처방 총금액	36,008,798
임의100/100 처방 총금액	107,910,631	임의100/100 처방 총금액	152,598,912	임의100/100 처방 총금액	159,911,816	총 456,430,157	

[표 3] 허가초과 항암화학요법 처방 제한 관련 업무진행 과정

진행일시	상세내용	비고
2020.04.22.	허가초과 항암화학요법 처방 제한 결정	상위 6개과 참석
2020.04.28.	처방제한 일정 및 회의내용 진료과 통보	
2020.05.22.	항암화학요법 리스트 전산 작업 완료	진료과는 조회만 가능
2020.05.26.	허가기준 외 처방에 대한 환자별 처방 확인	입원 · 외래 각과별 상호협조
2020.05.31.	기존 임의처방(100/100)처리건 유예기간 종료	
2020.06.01.	허가기준 외 처방에 대한 환자별 처방제한 시작	심사담당자가 처방 제한

- 또한 업무 진행 과정에서 진료각과 및 정보전산팀과 협력하여 [표 4]와 같이 병원 전산시스템인 PHIS에 □□□□□□□□ 홈페이지를 연계시켜 필요한 정보를 제공할 수 있도록 하고, 항암화학요법 처방내역을 전산시스템에 구현하여 진료의 편의를 도모하였다.

[표 4] 허가초과 항암화학요법 처방제한 관련 전산시스템 구축

전산시스템
구축 작업

병원 전산시스템 □□□□□□□□ 홈페이지 연계작업

항암화학요법

2007-01-01 ~

☐ 종로제외

[심평원항암화학요법사이트](#)

	요법코드	암종	세부암종	항암화학요법	투여대상	투여단계	투여요법	급여상제 사항	용법용량	급여인정일	급여종료일	신청진료과	진료의	제출서식
1	1006	자궁경	자궁경부암	paclitaxel + ifos	재발성 자궁	1차 이상	고식적요법	약값 일부 본인부	paclitaxel	2019-08-05	9999-12-31	혈액종양내과	고혈암	
2	1008	MELA	MELANOV	high-dose IL-2	전이성(sta	2차 이상	고식적요법	약값 일부 본인부	1st cycle	2016-01-01	9999-12-31	혈액종양내과	고혈암	
3	1010	CNS	역형성 핏	temozolomide	종양질환	1차 이상	고식적요법	약값 일부 본인	temozolom	2018-01-01	9999-12-31	신경외과	고혈암	

항암화학요법 처방내역 전산시스템에 구현

☒ 내원구분
 ☐ 전체
 ☐ 입원
 ☐ 외래
 ☐ 조회기간
 ☐ 실시일자
 ☐ 처방일자
 ~
 ~
☒ 항암제

☐ 급비
 ☐ 전체
 ☐ 급여
 ☐ 100/100
 ☐ 임의100
 ☐ 비급여
 ☐ 일반A
 ☐ 일반B
 ☐ 특별
 ☐ 일반C
 ☐ 처방불가

일반약제의 허가초과 비급여 약제 신청 유도

허가초과약제(비급여) 신청리스트

2013-01-01 ~

	접수일자	접수번호	주성분코드	주성분명	제품코드	제품명	수가코드	IRB 승인일자	처리결과	투여대상
1	2013-04-05	2013814000059		Verteporfin 15mg		비주다인주사 15mg, 한국노바티스		2013-03-22	승인	1. 투여대상급성 or 만성 or 재발성 중심정맥
2	2013-04-05	2013814000096		Methotrexate		엠.티.엑스정(메토트렉세이트), T,		2013-03-22	승인	스테로이드만으로 조절이 힘든 포도막염
3	2014-06-18	2014814000250		Bevacizumab 25mg/1r		아바스틴 주 100mg		2014-06-12	승인	1. 신생혈관관련 1. 습성노인성 황반변성 2. 특
4	2014-08-12	2014814000375		rituximab 10mg/ml		립테라 주 10, 50ml		2014-08-05	승인	자가면역성 뇌염(대표적으로 anti-NMDAR)
5	2014-11-10	2015814000017		human immunoglobuli		아이비글로불린에스엔주 0.5g/10r		2014-11-10	승인	1. 신장이식 관련 IVIG 치료 1) 이식전 교차

- 그리하여 2020.06.01.부터 허가기준 외 처방에 대해 보험관리팀 담당심사자가 익일에 처방내역을 심사하여 허가초과 처방을 확인하고 급여처방으로 변경하는 등의 관리가 이루어졌으며, 허가초과, 인정기준 외 약제에 대해서

는 임의비급여를 제한하여 급여로 처리·심사 마감하고 향후 관련 자료를 첨부하여 허가초과 비급여약제 신청을 유도하는 노력을 통해 [표 5]와 같은 결과를 이루어 병원의 진료비 삭감을 줄이고 수익 증대에 기여하였다.

[표 5] 처방제한 이후 진료과별 항암제 임의처방(100/100) 현황

2020년(06.01.~12.31.)		2021년 (01.01.~10.31)	
진료과	금액	진료과	금액
비뇨의학과	1,607,651	비뇨의학과	1,219,392
산부인과	566,431	혈액종양내과	2,358,451
소화기내과	176,372	호흡기알레르기내과	467,425
혈액종양내과	1,330,224	외과	158,340
호흡기알레르기내과	3,704,060	-	-
총합계	7,384,738	총합계	4,203,608

- 결론적으로 임의비급여 처리 방지를 위한 항암제 기준 내 처방 유도는 각종 정책 및 고시에 대한 정보를 명확하게 인지하고 이를 병원에 공유하여 신속하게 업무에 적용시킨 대표적인 사례로, 문제를 적극적으로 개선하고자 노력하는 자세는 환자와의 신뢰파괴, 민원, 법적다툼 등의 내재된 갈등 요소를 없애고 급변하는 의료시장의 변화에 정확하고 유연하게 대처하는 본보기로 병원의 귀감이 되는 바, 모범사례로 추천한다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

보험관리팀에서 시행중인 임의비급여 처리 방지를 위한 항암제 기준 내 처방 유도는 적정 의료서비스 제공 및 의료의 질을 향상시키며, 삭감을 방지하고 수익증대를 도모하는 등 병원 경영에도 중요한 역할을 하는 바, 지속적인 업무 수행이 가능하도록 위 모범사례를 치하하여 주시고, 적극적인 관심과 지원 바랍니다. (통보=모범사례)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 진료비 산정특례 적용 착오에 관한 사항

소관부서 부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 부산대학교병원 보험관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 보험관리팀에서는 의료법, 국민건강보험법, 의료급여법, 산업재해보상법, 자동차손해배상법등 관련 법령에 의거하여 진료비의 심사·청구·조정에 관한 업무를 처리하고 있으며, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 및 내부 규정에 따라 세부적인 업무를 수행한다.

2. 관계법령(판단기준)

「국민건강보험법 시행령」 제19조 제1항 [별표2] 제3호마목 중증질환자 산정특례 대상은 요양급여로 외래 또는 입원 진료 시 요양급여비용총액의 100분의 5에 해당하는 금액을 산정하고, 같은호나목2 희귀난치성질환자 산정특

례 대상은 요양급여비용총액의 100분의 10에 해당하는 금액을 산정하도록 되어있으며, 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준 [별표1~4]에 따라 적용 기간이 정해져 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 2018년부터 2020년까지 산정특례 적용과 관련하여 급여 본인부담금 및 급여 공단부담금이 잘못 수납되어 사후 심사를 통해 원무팀으로 재정산이 요청되고 있다. 외래는 2018년에 비해 점차 개선되고는 있으나 아직도 [표 1]과 같이 많은 건수가 반복적으로 발생되고 있으며, 이는 행정적인 낭비를 초래하고 병원의 진료비 계산에 대한 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 산정특례 적용 착오의 개선을 위해 외래의 경우 진료과와 원무팀에서 처방입력 및 수납 시 산정특례 적용여부 확인이 필수적으로 이루어지도록 교육을 강화하고, 확인절차 및 시스템의 보완이 요구되며, 입원의 경우 보험관리팀에서 사전 심사 후 진료비가 결정되는 만큼 자체적인 원인분석 등을 통해 적용 착오를 최소화하는 방안을 마련할 필요가 있다.

[표 1] 산정특례 적용 착오 발생 건수

년도	외래	입원
2018년도	1200건	14건
2019년도	833건	52건
2020년도	560건	38건
총계	2,593건	104건

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

진료비 산정특례 적용 착오의 문제점을 관련 부서와 협의하여 원인을 분석하고 그에 따른 대책을 마련하여 적용 착오가 최소한으로 이루어지게 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

산정특례 적용 착오의 개선을 위해 관련 부서와 충분히 협의하여 산정특례 적용 여부 확인이 필수적으로 이루어질 수 있도록 교육 및 시스템을 강화하고, 자체적인 원인분석을 통하여 적용 착오를 최소화할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 전액본인부담(100/100) 적용 가능 품목 관리 철저

소관부서 부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 부산대학교병원 보험관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 보험관리팀에서는 의료법, 국민건강보험법, 의료급여법, 산업재해보상법, 자동차손해배상법등 관련 법령에 의거하여 진료비의 심사·청구·조정에 관한 업무를 처리하고 있으며, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 및 내부 규정에 따라 세부적인 업무를 수행한다.

2. 관계법령(판단기준)

「국민건강보험법 시행령」 제22조(약제·치료재료의 요양급여비용) 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조(요양급여의 적용기준 및 방법)에 의거하여 「약제·치료재료에 대한 요양급여비용의 결정 기준·절

차」와 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(약제)」 등 그 밖에 필요한 사항은 ○○○○○장관이 정하여 고시하며, ○○○○○장관이 비급여 대상으로 정한 것을 제외한 일체의 것과 약제의 경우 요양급여대상으로 결정 및 고시한 것에 대하여 요양급여의 방법·절차·범위·상한 등의 기준은 ○○○○○령으로 정한다.

3. 감사결과 확인된 문제

전액본인부담(100/100) 약제란 ○○○○○장관이 별도로 정한 약제품목에 대하여 허가사항 범위 이내이나 별도로 정해진 급여기준 이외 투여 시 약값을 환자 본인이 100% 부담하는 것으로, 2018년에서 2020년까지 보험관리팀의 삭감 상세내역을 살펴본 결과, [표 1]과 같이 급여기준 이외 전액본인 부담 가능한 품목을 환자에게 부담시키지 아니하고 청구하여 삭감된 사실이 확인되었다. 또한 삭감 이후 환자에게 징수하는 것은 사전 설명의 미흡 등 현실적으로 불가능하며, 징수한다고 할지라도 진료비 계산에 대한 불신 등 병원 이미지 및 신뢰도에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 이러한 품목의 사용이 잦은 진료과에는 적극적으로 안내하여 반복적인 삭감을 방지하고, 환자에게는 사전에 충분한 설명이 가능하도록 해당 품목에 대한 관리 강화가 필요하다.

[표 1] 전액본인부담 가능 품목 삭감 내역

(단위:원)

순번	수가명	진료과	고시내용	고시번호 (최근)	삭감금액 (2018~2020년)
1	오저텍스 이식제 700mcg	안과	◎ 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	제2018-253호	841,111
2	루센티스주, 루센티스 프리필드시린지	안과		제2021-101호	39,914,991
3	아일리아주사	안과		제2021-101호	48,073,980

순번	수가명	진료과	고시내용	고시번호 (최근)	삭감금액 (2018~2020년)
4	레미케이드 주 100 MG	소화기 내과, 정형외과	◎ 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	제2020-305호	13,521,756
5	유니레이 프리필드 주사	신경과. 신경외과	◎ 뇌, 뇌혈관, 경부혈관 자기공 명영상진단(MRI) 급여기준 MRI삭 감과 같이 삭감	제2020-045호	1,168,670 MRI 별도 (31,046,183)
6	헥사메딘, 탄툼 가글액 (가글액 종류)	전체 진료과	◎ 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	제2018-253호	593,462
7	당뇨약제	전체 진료과	◎ 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	제2021-127호	4,266,364
8	뉴론틴 (Gabapentin)	전체 진료과		제2019-191호	6,556,707
9	리리카 (Pregabalin)	전체 진료과		제2019-191호	7,014,212
10	뇌경색 항혈전제 1종만 급여	전체 진료과	◎ 뇌경색에 2종을 보험으로 처 방하여 1종 삭감(투여비용이 저렴 한 약제 전액본인부담)	제2018-081호	1,432,729
11	뇌기능개선제 기넥신, 케타스,타나민, 서규록신	전체 진료과	◎ 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여 인정하며, 동 인정기 준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (신경과 뇌혈관질환에 뇌기능개선 제 2종 보험으로 처방 1종 삭감)	제2018-253호	487,645

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

전액본인부담 가능한 품목이 청구되어 삭감되는 것을 방지하기 위해 해당 사례를 조사하는 등 진료각과와 협의하여 삭감 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

진료각과를 대상으로 전액본인부담 가능한 품목을 사전 안내하고, 반복적으로
삭감이 일어나지 않도록 조치하는 등 관련 부서와 협의하여 삭감 방지를 위한
대책을 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제 목 자동차보험 삭감 관련 수가 관리 미흡

소관부서 부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 부산대학교병원 보험관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 보험관리팀에서는 의료법, 국민건강보험법, 의료급여법, 산업재해보상법, 자동차손해배상법 등 관련 법령에 의거하여 진료비의 심사·청구·조정에 관한 업무를 처리하고 있으며, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 및 내부 규정에 따라 세부적인 업무를 수행한다.

2. 관련법령(판단근거)

「자동차손해배상 보장법」 제2조에 따르면 “자동차보험진료수가”란 자동차의 운행으로 사고를 당한 자가 「의료법」에 따른 의료기관에서 진료를 받음으로서 발생하는 비용을 말하는 것으로, 「자동차보험진료수가에 관한 기

준」 제5조(진료수가의 인정범위) 제1항제1호에 따르면 「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항에 따라 ○○○○○장관이 정한 내역 및 기준을 자동차보험 진료수가의 인정범위에 포함하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

교통사고 환자에게 사용하는 치료재료는 건강보험에서 요양급여 대상인 치료재료를 우선 인정하고, 비급여대상으로 정해진 치료재료는 요양급여 대상 치료재료 중 대체가능한 치료재료가 없거나 환자의 증상 및 질병의 정도에 따라 진료 상 반드시 필요한 경우 사례별로 인정된다. 하지만 2018년부터 2021년 9월까지 자동차보험 삭감현황 및 상세내역을 살펴본 결과, 동일 목적 동일분류군 중 건강보험으로 등재된 치료재료를 처방하여야 함에도 [표 1] 과 같이 비급여항목의 치료재료를 처방하여 삭감된 사실을 확인하였다.

[표 1] 자동차보험 삭감내역 중 비급여(치료재료) 수가 현황

(단위: 원)

연월	구분	진료과	환자명	삭감 코드	수가명	삭감액
201806	입원	신경외과		08C	CG CERVICAL SPACER(전규격)	3,100,000
201811	입원	성형외과		08C	MEGADERM(0.3-0.6MM)	1,440,000
201903	입원	신경외과		08C	DEMIO(1CC)	380,000
201903	입원	성형외과		08C	MEDPOR(81024)	1,400,000
201904	입원	신경외과		08C	CANCELLOUS COARSE(30CC)	479,560
201905	입원	신경외과		08C	MEDISHIELD ANTI-ADHESION GEL(1CC)	270,000
201906	입원	이비인후과		08C	GUARDCEL(8CM)	108,000
201907	입원	이비인후과		08C	GUARDCEL(8CM)	108,000
201907	입원	신경외과		08C	1 PRIMARY WOUND DRESSING(17ML)	315,000
201908	입원	정형외과		08C	REGENCOL(3G)	150,000
201908	입원	정형외과		08C	GENERAL SURGERY SET(HIP,KNEE 포함)(4740-061)	180,000
201909	입원	외상외과		08C	GENERAL SURGERY SET(HIP,KNEE 포함)(4740-061)	180,000

연월	구분	진료과	환자명	삭감 코드	수가명	삭감액
201910	입원	신경외과		08C	DBX(1CC)	456,000
201912	입원	신경외과		08C	1 PRIMARY WOUND DRESSING(17ML)	105,000
202001	입원	정형외과		08C	RAFUGEN DBM GEL PRO(3CC)	855,000
202004	입원	신경외과		08C	DBX(1CC)	456,000
202004	입원	신경외과		08C	DBX(1CC)	456,000
202006	입원	외상외과		08C	TIBIALIS ANTERIOR(전규격)	1,128,830
202007	입원	신경외과		08C	CANCELLOUS COARSE(10CC)	250,490
202008	입원	신경외과		08C	MEGADERM(0.3-0.6MM)	360,000
202012	입원	정형외과		08C	RAFUGEN DBM GEL PRO(3CC)	855,000
202012	입원	신경외과		08C	CGDERM IMPLANT(0.23~0.33)	1,400,000
202106	입원	외상외과		08C	NASOPORE FORTE PLUS(8CM)(창상피복제)	241,300
202106	입원	외상외과		08C	COLLATAMP G(10*10)	300,800
202108	입원	정형외과		08C	노보시스(NOVOSIS)(1MG)	1,650,000
합계						16,624,980

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 관련 법령 및 기준을 준수하여 자동차보험진료수가 관리에 철저를 기하여 향후에는 유사한 사례가 반복되는 일이 없도록 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

자동차손해배상 보장법 및 자동차보험진료수가에 관한 기준 등 자동차보험과 관련한 기준이 따로 규정되어 있어 별도의 관리가 필요한 수가들이 있으므로, 향후 이러한 사례가 반복되지 않도록 실질적인 검토를 통하여 자동차보험진료수가의 관리를 강화하고, 병원의 실정에 맞도록 업무를 개선하시기 바랍니다. (개선)

부 산 대 학 교 병 원

시정요구 및 통보

제 목 청구 사후관리 및 업무처리 미흡

소관부서 부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 부산대학교병원 보험관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 보험관리팀에서는 의료법, 국민건강보험법, 의료급여법, 산
업재해보상법, 자동차손해배상법 등 관련 법령에 의거하여 진료비의 심사·
청구·조정에 관한 업무를 처리하고 있으며, 국민건강보험 요양급여의 기준
에 관한 규칙 및 내부 규정에 따라 세부적인 업무를 수행한다.

2. 관련법령(판단근거)

「사무관리규정」 제4조(문서의 성립 및 효력)에 따르면 문서는 다른 특별한
규정이 없는 한 당해 문서에 대한 서명(전자문서명포함)에 의한 결재가 있음
으로써 성립하며, 문서가 수신자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생하는 도달

주의를 원칙으로 하며, 「부산대학교병원 위임전결규정」 별표#1에 따라 건강보험·의료급여·산재 등 업무의 일반적인 사항에 대해서는 부서장의 결재를 받도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

보험관리팀에서는 진료비 청구 및 관리에 관한 전반적인 업무를 수행하면서 진료비의 조정 등 문제가 있거나 자격에 변동이 있어 반송되는 건들에 대해서도 원무팀 및 진료과들과 유기적인 협조를 통하여 사유를 보완하고 재청구하여 수입의 누락이 생기지 않도록 사후관리를 하여야 한다. 이와 관련하여 2018년부터 2020년까지 청구 후 반송 현황 및 사후처리 유무에 대하여 살펴본 결과, 반송 건에 대한 내역을 전자문서가 아닌 유선 및 메신저를 통해 처리하고 있어 부서장의 결재가 누락 되는 등 보고체계가 미흡하였으며, 감사일 현재(2021.11.16.)까지 처리되지 않은 반송 건이 [표 1]과 같이 확인되었다.

[표 1] 최근 3년간 반송건 미처리 현황

(단위: 원)

구분	청구일자	환자번호	환자명	반송사유	청구액
외래	2019.05.23			보험료체납 공단반송으로 전액본인부담 원무재정산	0
외래	2019.05.23			보험료체납 공단반송으로 전액본인부담 원무재정산	0
외래	2019.05.28			산재급종으로 변경	22,610
외래	2019.05.31			보험료체납 공단반송으로 전액본인부담 원무재정산	0
외래	2019.06.18			△△△△△△△분 자격점검 후 지급불능(급여제한자)으로 체납자	0
외래	2019.06.28			산재급종으로 변경	3,050
외래	2019.07.10			보험료체납 공단반송으로 전액본인부담 원무재정산	0

구분	청구일자	환자번호	환자명	반송사유	청구액
외래	2019.07.23			진료일자 오류	151,400
외래	2019.09.18			진료일자 오류	326,510
외래	2019.10.21			자동차보험으로 급종 변경	4,980
외래	2020.04.27			산재급종으로 변경	68,540
외래	2020.04.27			산재급종으로 변경	3,090
외래	2020.10.22			틀니등록번호 등록 오류	287,290

※ 체납자 진료비는 100/100으로 환자 본인부담 하고 0원으로 청구

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 관련 규정을 준수하여 타부서와 협의를 통한 업무에 대해서는 결재권자의 승인을 득하여 업무를 처리하고, 향후 반송 건에 대한 처리가 누락되지 않도록 사후관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

감사일 현재까지 처리되지 않은 반송 건에 대해서 빠른 시일내에 재청구 될 수 있도록 조치하시기 바라며, (시정) 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 사후관리에 철저를 기하고, 타부서와 연계된 업무 및 보고에 대해서는 위임전결규정의 전결사항을 준수하여 업무를 처리하시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 이의신청 부제기 사유 세분화에 따른 삭감관리 철저

소관부서 부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 부산대학교병원 보험관리팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 보험관리팀에서는 의료법, 국민건강보험법, 의료급여법, 산업재해보상법, 자동차손해배상법 등 관련 법령에 의거하여 진료비의 심사·청구·조정에 관한 업무를 처리하고 있으며, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 및 내부 규정에 따라 세부적인 업무를 수행한다.

2. 관계법령

「국민건강보험법」 제87조(이의신청), 「의료급여법」 제30조(이의신청 등), 「산업재해보상보험법」 제45조(진료비의 청구 등), 「자동차손해배상 보장법」 제19조(자동차보험진료수가의 심사 청구 등)에 의한 진료비 심사, 청

구, 이의신청, 심판청구 등에 따라 진료비를 심사 청구할 수 있으며, 해당 기관의 심사처분 및 결과에 이의가 있는 때에는 이의신청을 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

관련 법령에서 정한 바에 따라 진료비를 심사 청구하고, 삭감된 내용에 대해서는 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청을 하지 않거나 하지 못하는 경우에는 급여기준 초과, 본인부담률 적용 착오, 허가초과, 의료진 의사결정 등 다양한 부제기 사유가 존재한다. 하지만 보험관리팀에서 실시한 2018년 1월부터 2020년 12월까지의 심사 청구 후 삭감된 내역 중 부제기 현황을 살펴본 결과, 많은 사유가 있음에도 ‘허가외 처방, 통합기록에 사유 미 존재’라는 단일한 사유로 관리되고 있는 사실을 확인하였다. 이의신청 부제기 사유가 단일한 것은 삭감의 원인분석에 효과적이지 못하며, ‘통합기록에 사유 미 존재’라는 통합문구는 기록에 없는 행위에 대한 허위청구라는 의미로 오해될 소지가 있다.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

보험관리팀에서는 청구 후 삭감된 내용에 대해서 이의신청 부제기에 해당하는 사유를 명확히 인지하고 세분화하여 삭감의 원인을 파악하는데 활용하는 등 능동적인 삭감관리가 가능하도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

청구 후 삭감된 내용에 대해서 이의신청 부제기에 해당하는 경우, 그 사유를 명확히 인지하고 상세하게 구분하여 삭감의 원인을 분석하는 자료로 활용하는 등 효과적이고 지속적인 삭감관리가 될 수 있도록 만전을 기해주시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

시정요구

제 목 복무관리[보건휴가(임신검진)] 부적정

소관부서 부산대학교병원 보험관리팀

조치부서 부산대학교병원 보험관리팀, 인력개발팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 보험관리팀에서는 의료법, 국민건강보험법, 의료급여법, 산업재해보상법, 자동차손해배상법 등 관련 법령에 의거하여 진료비의 심사·청구·조정에 관한 업무를 처리하고 있으며, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 및 내부 규정에 따라 세부적인 업무를 수행한다.

2. 관계법령

「단체협약」 제76조(보건휴가)에 따르면 ‘병원은 여성 조합원에게 보건휴가 및 임신 중 검진휴가의 월1회 자유로운 사용을 보장하며, 이를 사용하고자 할 때에는 사전에 휴가 사용 신청을 하여야 한다. 또한 연차휴가를 사용할 경

우 보건휴가를 먼저 사용하고, 임신 중 검진 휴가는 유급으로 한다'라고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

최근 3년간(2018. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)보험관리팀 직원들이 사용한 보건휴가(임신검진) 내역을 살펴본 결과, [표 1]과 같이 ◇◇◇ 직원이 2019년 6월에 보건휴가(임신검진)를 1회 초과하여 사용한 사실을 확인하였다.

[표 1] 보건휴가(임신검진) 초과 사용 현황

사번	이름	보건휴가(임신검진)			회수금액 (연차수당)
		부여횟수	사용횟수	초과사용횟수	
2006316	◇◇◇	월 1회 (유급)	1.5회	0.5회	80,280원

* ◇◇◇ 보건휴가(임신검진) 사용일: 2019년 6월 5일(1일), 6월17일(반일)

4. 관계부서 등의 및 검토결과

보험관리팀에서는 '단체협약' 및 '복무규정'을 준수하여 복무관리[보건휴가(임신검진)]를 철저하게 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

<조치할 사항> 부산대학교병원장은

직원들이 휴가[보건휴가(임신검진)]를 실시할 경우 휴가의 사용목적에 맞는 사용 가능한 휴가 일수를 고려하여 사용할 수 있도록 관리하여 주시고, ◇◇◇ 직원의 보건휴가(임신검진) 초과 사용분 80,280원은 회수 조치하시기 바랍니다.
(시정)